

PEMBELAJARAN LENGKAP CLINICAL MEDICINE 1st EDITION



ROXWOOD
H O S P I T A L

DISUSUN OLEH:

dr. Chocho Arata, Sp. Og

NOTE:

**BUKU PEMBELAJARAN INI TIDAK SEPENUHNYA SEPERTI YANG ASLI.
NAMUN, SEMUA YANG DISUSUN SESUAI DENGAN MEDICAL HANDBOOK.**

BAB 1.

THINKING ABOUT MEDICINE (BERPIKIR SEBAGAI DOKTER)

Tujuan Bab

Mentransformasi pola pikir Co.Assist menjadi pola pikir dokter yang bertanggung jawab, reflektif, aman secara klinis, dan berorientasi pada pasien.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan peserta mampu:

1. Menjelaskan peran dokter sebagai profesi berbasis kepercayaan publik.
2. Menggunakan kerangka berpikir klinis yang sistematis dan probabilistik.
3. Mengidentifikasi serta memitigasi bias kognitif.
4. Menunjukkan profesionalisme, empati, dan akuntabilitas.
5. Melakukan refleksi diri terhadap kesalahan klinis.

Bab 1.1. Identitas & makna profesi dokter

Inti Konsep:

- Dokter adalah penjaga keselamatan pasien (patient safety first).
- Pasien adalah manusia utuh, bukan sekedar diagnosis.

Step-by-step (Roleplay)

1. Dokter memperkenalkan diri dengan jelas (nama, peran, tanggung jawab).
2. Menjelaskan batas kompetensi dan peran supervisi.
3. Mengonfirmasi harapan pasien terhadap perawatan.

Checklist Evaluasi

- Bahasa jelas & sopan
- Transparansi peran
- Tidak menjanjikan hasil di luar kendali

Bab 1.2. Etika, Nilai, dan Profesionalisme

Inti Konsep

- Beneficence, non-maleficence, autonomy, justice.
- Kerahasiaan medis dan informed consent.

Step-by-Step

1. Identifikasi dilemma etika pada kasus simulasi.
2. Petakan prinsip etika yang terlibat.
3. Tentukan keputusan paling aman bagi pasien.
4. Diskusikan dengan supervisor bila ragu.

Skenario Roleplay

- Pasien menolak Tindakan penting.
- Permintaan keluarha bertentangan dengan keinginan pasien.

Bab 1.3. Kerangka berpikir klinis (Clinical Reasoning)

Inti Konsep

- Pattern recognition vs analytical reasoning.
- Probabilistik, bukan kepastian absolut.

Step-by-Step Berpikir klinis

1. Tangkap keluhan utama (atau signal).
2. Bentuk hipotesis awal (top 3 diagnosis).
3. Kumpulkan data penyangga/penyangkal.
4. Revisi hipotesis secara iteratif.
5. Tentukan rencana aman (Rule out worst-case)

Alat Bantu

- Problem List
- Red Flags
- Time-critical diagnoses

Bab 1.4. Bias Kognitif & Kesalahan Klinis

Inti Konsep

- Confirmation bias, anchoring, availability.

Step-by-Step

1. Sadari asumsi awal.
2. Cari data yang menyangkal diagnosis utama.
3. Gunakan differential diagnosis tertulis.
4. Mintakan second opinion pada tenaga medis atau rekan medis yang lain bila perlu.

Kasus pada Roleplay

- Kasus salah diagnosis awal, wajib koreksi berdasarkan atau berbasis data.

Bab 1.5 Being Wrong & Duty of Candour

Inti Konsep

- Kesalahan Adalah bagian dari praktik, menutupinya adalah pelanggaran.

Step-by-Step Disclosure Error

1. Identifikasi dan amankan pasien terlebih dahulu.
2. Laporkan ke supervisor atau jabatan lebih tinggi dari jabatan diri sendiri.

3. Sampaikan kepada pasien dengan jujur dan empatik.
4. Jelaskan langkah perbaikan.
5. Dokumentasikan dengan benar.

Bab 1.6. Komunikasi klinis Dasar

Inti Konsep

- Mendengarkan aktif dan dengan bahasa awam.

Step-by-Step

1. Bangun rapport / report.
2. Dengarkan tanpa menyela terlebih dahulu.
3. Ringkas dan konfirmasi pemahaman.
4. Beri kesempatan bertanya.

Bab 1.7. Refleksi Diri & Pembelajaran Berkelanjutan

Inti Konsep

- Reflective Practice.

Step-by-Step (Gibbs)

1. Deskripsi kejadian.
2. Perasaan.
3. Evaluasi.
4. Analisis.
5. Kesimpulan.
6. Rencana perbaikan.

Bab 1.8. Integrasi Mindset COAS – Dokter

Tujuan Menyatukan seluruh konsep pada BAB 1 menjadi pola kerja harian dokter muda.

Step-by-Step Integrasi Praktis.

1. Sebelum bertemu pasien

- Tanyakan pada diri sendiri: *Apa risiko terburuk jika saya salah?*
- Identifikasi batas kompetensi pribadi.

2. Saat bertemu pasien

- Hadir penuh (presence): Kontak mata, bahasa tubuh terbuka pasien.
- Dengarkan keluhan tanpa menyela +/- 1 menit pertama.

3. Saat berpikir klinis

- Tulis problem list singkat.
- Tentukan 3 diagnosis paling mungkin.
- Tandai red flags.

4. Saat mengambil keputusan

- Pilih tindakan paling aman.
- Libatkan pasien dalam keputusan.

5. Setelah tindakan

- Refleksi singkat: apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki.

Bab 1.9. Contoh Roleplay (SCRIPTED)

Skenario: Dokter Muda (Co.assist), Dokter Umum pertama kali menangani pasien sendiri.

Langkah:

1. Perkenalan profesional
2. Klarifikasi peran & supervisi
3. Mendengarkan keluhan
4. Menyampaikan rencana awal
5. Menutup dengan empati

Contoh Dialog Singkat:

” Saya dr. dokter yang bertugas hari ini. Saya akan memeriksa sir/mam. Dan semua keputusan akan kami diskusikan dengan asisten saya atau dokter penanggung jawab.”

Bab 1.10. Kesalahan Umum Co.ass & Koreksi

KESALAHAN UMUM	KOREKSI SEBAGAI DOKTER
Takut Bertanya	Bertanya = Bertanggung jawab
Fokus diagnosis	Fokus keselamatan pasien
Terlalu yakin	Rendah hati klinis

Bab 1.11 Checklist Kompetensi

Lulus bab 1 jika peserta mampu:

- Menjelaskan peran dokter secara etis.
- Menunjukkan komunikasi profesional
- Mengidentifikasi bias berpikir
- Melakukan refleksi diri tertulis

RINGKASAN

Bab ini adalah fondasi seluruh praktik kedokteran. Tanpa mindset yang benar, keterampilan teknis menjadi berbahaya. Dokter yang baik berpikir sebelum bertindak, bersikap jujur saat salah, dan selalu menempatkan pasien sebagai pusat keputusan.

BAB 2.

HISTORY TAKING & PHYSICAL EXAMINATION (ANAMNESIS & PEMERIKSAAN FISIK)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda atau dokter umum kemampuan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang **aman, sistematis, berfokus diagnosis, dan manusiawi**, sebagai fondasi utama pengambilan Keputusan klinis.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan anamnesis terstruktur dan fleksibel sesuai konteks klinis.
2. Menggali informasi relevan tanpa kehilangan empati.
3. Melakukan pemeriksaan fisik sistematis dan berorientasi pada masalah yang dihadapi.
4. Menghubungkan temuan anamnesis dan Pemeriksaan Fisik (PF) dengan penalaran klinis.
5. Menghindari kesalahan umum Co.Ass saat menghadapi pasien.

Bab 2.1. Prinsip Dasar Anamnesis Klinis

Inti Konsep

- 80% diagnosis berasal dari anamnesis yang baik.
- Anamnesis Adalah **Interaksi Terapeutik**, bukan interogasi.
- Fleksibel mengikuti pasien, bukan template kaku.

Mindset Dokter

- Pasien tidak selalu menyampaikan keluhan dengan istilah medis.
- Dengarkan narasi sebelum mengarahkan

Bab 2.2 Step-by-Step Anamnesis Lengkap

Langkah 1 – Pembukaan & Rapport

1. Perkenalkan diri (nama, peran).
2. Konfirmasi identitas pasien.
3. Pastikan kenyamanan dan privasi.
4. Ajukan pertanyaan pembuka terbuka.

“Apa yang membuat Bapak/Ibu datang hari ini?”

Langkah 2 – Keluhan Utama

- Catat dengan **kata pasien sendiri**.
- Satu kalimat jelas.

Contoh:

Nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum masuk RS.

Langkah 3 – Riwayat Penyakit Sekarang (HPI)

Gunakan kerangka **OPQRST / OLDCART**, disesuaikan kasus.

- Onset
- Provocation / Palliation
- Quality
- Region / Radiation
- Severity
- Time course

Fokus Dokter

- Kronologi logis
- Red flags
- Progressivitas

Langkah 4 – Review of Systems (Selective)

- Hanya sistem relevan.
- Jangan menjadi checklist kosong.

Langkah 5 – Riwayat Penyakit Dahulu

- Penyakit kronis
- Rawat inap sebelumnya
- Operasi

Langkah 6 – Riwayat Obat & Alergi

- Obat rutin
- Obat bebas / herbal
- Reaksi alergi nyata vs efek samping

Langkah 7 – Riwayat Keluarga

- Penyakit genetik
- Penyakit kardiovaskular dini

Langkah 8 – Riwayat Sosial & Psikologis

- Pekerjaan
- Merokok, alkohol, zat lain
- Dukungan keluarga
- Stressor psikososial

Bab 2.3 Kesalahan Umum COAS dalam Anamnesis

Kesalahan	Dampak	Koreksi
Terlalu cepat menyela	Informasi hilang	Diam aktif 60–90 detik
Terjebak template	Kehilangan konteks	Fleksibel
Menggunakan istilah medis	Pasien bingung	Bahasa awam

Bab 2.4 Pemeriksaan Fisik: Prinsip Umum

Inti Konsep

- Dilakukan untuk **menjawab hipotesis klinis**, bukan ritual.
- Sopan, sistematis, dan efisien.

Prinsip Dasar

1. Jelaskan setiap tindakan.
2. Jaga privasi.
3. Mulai dari tidak invasif.

Bab 2.5 Step-by-Step Pemeriksaan Fisik Umum

Langkah 1 – General Survey ABCDE

- AIRWAY
- BREATHING
- CIRCULATION
- DISABILITY
- EXPOSURE

Langkah 2 – Tanda Vital

- Tekanan Darah
- Denyut Nadi
- Laju Pernapasan
- Suhu

- SpO₂

Langkah 3 – Pemeriksaan Sistemik

Disesuaikan dengan keluhan utama:

- Kardiovaskular
- Respirasi
- Abdomen
- Neurologi

Bab 2.6 Integrasi Anamnesis & Pemeriksaan Fisik

Step-by-Step Clinical Integration

1. Ringkas masalah utama.
2. Buat problem list.
3. Tentukan diagnosis kerja.
4. Susun diagnosis banding.
5. Identifikasi kondisi gawat.

Bab 2.7 Contoh Roleplay Lengkap

Kasus: Pria 45 tahun, nyeri dada

Fokus Penilaian:

- Anamnesis nyeri dada sistematis
- Pemeriksaan jantung & paru
- Komunikasi profesional

Bab 2.8 Checklist Kompetensi Bab 2

Peserta dinyatakan kompeten bila mampu:

- Membuka anamnesis dengan empati
- Menyusun kronologi jelas
- Melakukan Pemeriksaan Fisik sistematis
- Menghubungkan data dengan DD

RINGKASAN

Bab ini mengajarkan bahwa **anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah seni dan ilmu**. Dokter yang baik tidak sekadar bertanya dan memeriksa, tetapi memahami cerita pasien dan mengubahnya menjadi keputusan klinis yang aman.

BAB 3.

CARDIOVASCULAR MEDICINE (PENYAKIT KARDIOVASKULAR)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali, menilai, dan menangani masalah kardiovaskular** secara sistematis, aman, dan tepat waktu, khususnya kondisi yang **mengancam nyawa**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian awal keluhan kardiovaskular secara cepat dan akurat.
2. Mengidentifikasi red flags kardiovaskular.
3. Menyusun diagnosis kerja dan banding rasional.
4. Menentukan tatalaksana awal dan indikasi rujukan.
5. Berkomunikasi efektif pada kasus kardiovaskular akut.

Bab 3.1 Prinsip Dasar Kardiovaskular untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Penyakit jantung sering **time-critical**.
- Jangan lewatkan kondisi fatal meskipun gejala ringan.
- Prioritas: **rule out worst-case scenario**.

Worst-Case Diagnoses yang Harus Disingkirkan

- Acute Coronary Syndrome (ACS)
- Aortic dissection
- Pulmonary embolism
- Tamponade jantung
- Malignant arrhythmia

Bab 3.2 Step-by-Step Pendekatan Keluhan Kardiovaskular

Langkah 1 – Primary Survey (Bila Akut)

- Airway
- Breathing
- Circulation
- Disability
- Exposure

Jika tidak stabil → tangani dahulu, anamnesis singkat.

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Kardiovaskular

Keluhan utama umum:

- Nyeri dada
- Palpitasi
- Sesak napas
- Sinkop

Nyeri Dada (Pendekatan Sistematis)

- Onset & durasi
- Lokasi & radiasi
- Karakter (tekan, tajam, terbakar)
- Faktor pencetus & pereda
- Gejala penyerta (mual, diaphoresis)

Langkah 3 – Faktor Risiko Kardiovaskular

- Usia
- Hipertensi
- Diabetes
- Merokok
- Dislipidemia
- Riwayat keluarga

Bab 3.3 Pemeriksaan Fisik Kardiovaskular Step-by-Step

Langkah 1 – General Survey

- Distress
- Sianosis
- Edema

Langkah 2 – Tanda Vital

- TD kedua lengan
- Nadi (frekuensi & irama)

Langkah 3 – Pemeriksaan Jantung

- Inspeksi: ictus cordis
- Palpasi
- Auskultasi (S1, S2, murmur)

Langkah 4 – Pemeriksaan Pendukung

- JVP

- Edema perifer
- Paru

Bab 3.4 Diagnosis Kerja & Banding

Contoh (Nyeri Dada)

Diagnosis kerja: ACS

Diagnosis banding:

- Angina stabil
- Perikarditis
- Diseksi aorta
- GERD

Bab 3.5 Pemeriksaan Penunjang

Prinsip

- Mendukung keputusan klinis, bukan menggantikan.

Pemeriksaan Utama

- EKG 12 lead (≤ 10 menit)
- Troponin
- Foto toraks

Bab 3.6 Tatalaksana Awal (First Hour Management)

Prinsip

- Time is myocardium.

ACS Awal (Simulasi)

- Oksigen bila hipoksia
- Aspirin
- Nitrat (jika tidak kontraindikasi)
- Analgesia
- Monitoring

Semua di bawah supervisi & protokol RS.

Bab 3.7 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pria 58 tahun, nyeri dada mendadak

Penilaian Roleplay

- Kecepatan pengenalan ACS
- Keamanan tindakan awal
- Komunikasi urgensi ke pasien & keluarga
- Koordinasi tim

Bab 3.8 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Menganggap nyeri dada ringan	Fatal	Rule out ACS
Menunda EKG	Miss diagnosis	EKG dini
Fokus satu diagnosis	Bias	DD tertulis

Bab 3.9 Checklist Kompetensi Bab 3

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenali red flags kardiovaskular
- Melakukan penilaian cepat
- Menyusun diagnosis kerja
- Menginisiasi tatalaksana awal aman

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **kewaspadaan dan kecepatan** adalah kunci pada penyakit kardiovaskular. Dokter muda harus selalu berpikir paling berbahaya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan yang jinak.

BAB 4.

RESPIRATORY / CHEST MEDICINE (PENYAKIT SALURAN NAPAS)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai, menstabilkan, dan menangani gangguan pernapasan** secara cepat, aman, dan sistematis, dengan fokus pada kondisi yang **mengancam nyawa**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Mengenali tanda kegawatan respirasi.
2. Melakukan pendekatan sesak napas secara terstruktur.
3. Menyusun diagnosis kerja dan banding respirasi.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
5. Berkomunikasi efektif pada pasien dengan distress napas.

Bab 4.1 Prinsip Dasar Respiratory Medicine untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **Sesak napas = potensi gawat darurat** sampai terbukti sebaliknya.
- Prioritas utama: oksigenasi dan ventilasi.
- Jangan menunda tindakan hanya untuk melengkapi anamnesis.

Kondisi Fatal yang Harus Selalu Dipikirkan

- Gagal napas akut
- Asma akut berat
- Pneumotoraks tension
- Pulmonary embolism
- Pneumonia berat / sepsis

Bab 4.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Sesak Napas

Langkah 1 – Primary Survey (ABCDE)

- **A:** Pastikan jalan napas paten
- **B:** RR, SpO₂, penggunaan otot bantu
- **C:** Nadi, TD, perfusi
- **D:** Kesadaran
- **E:** Paparan dada, trauma, ruam

Bila tidak stabil → stabilisasi dulu, anamnesis singkat.

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Respirasi

Pertanyaan kunci:

- Onset sesak (tiba-tiba vs bertahap)
- Faktor pencetus
- Riwayat asma/COPD
- Batuk, dahak, hemoptisis
- Nyeri dada pleuritik

Langkah 3 – Faktor Risiko Respirasi

- Merokok
- Paparan debu/kimia
- Imobilisasi lama
- Riwayat TB

Bab 4.3 Pemeriksaan Fisik Respirasi Step-by-Step

Langkah 1 – Inspeksi

- Pola napas
- Retraksi
- Sianosis

Langkah 2 – Palpasi

- Ekspansi dada
- Fremitus

Langkah 3 – Perkusi

- Hipersonor (pneumotoraks)
- Redup (konsolidasi/efusi)

Langkah 4 – Auskultasi

- Wheezing
- Crackles
- Silent chest (bahaya)

Bab 4.4 Diagnosis Kerja & Banding Respirasi

Contoh (Sesak Akut)

Diagnosis kerja: Asma akut berat

Diagnosis banding:

- Pneumonia
- Edema paru
- Pneumotoraks
- Emboli paru

Bab 4.5 Pemeriksaan Penunjang**Prinsip**

- Jangan menunda terapi penyelamatan nyawa.

Pemeriksaan Umum

- SpO₂ kontinu
- Foto toraks
- AGD (bila tersedia)

Bab 4.6 Tatalaksana Awal Respirasi (First Hour)**Prinsip**

- Air goes in, CO₂ goes out.

Contoh Asma Akut

- Oksigen
- Nebulisasi bronkodilator
- Steroid sistemik
- Monitoring ketat

Semua sesuai protokol RS dan supervisi.

Bab 4.7 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Wanita 30 tahun, sesak napas mendadak

Penilaian Roleplay

- Kecepatan stabilisasi
- Ketepatan diagnosis kerja
- Keamanan terapi awal
- Komunikasi dengan pasien panik

Bab 4.8 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Menunda oksigen	Hipoksia	Oksigen dini
Menganggap sesak ringan	Deteriorasi cepat	Waspada
Tidak nilai RR	Miss severity	RR wajib

Bab 4.9 Checklist Kompetensi Bab 4

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenal distress respirasi
- Melakukan ABCDE
- Menyusun diagnosis kerja respirasi
- Menginisiasi tatalaksana awal aman

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **gangguan pernapasan adalah kondisi yang cepat berubah**. Dokter muda harus berpikir cepat, bertindak aman, dan selalu memprioritaskan oksigenasi pasien.

BAB 5.

ENDOCRINOLOGY (PENYAKIT ENDOKRIN)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali, menilai, dan menangani gangguan endokrin yang sering ditemui di IGD dan bangsal**, dengan fokus pada kondisi **metabolik akut yang mengancam nyawa**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Mengidentifikasi kegawatan endokrin (hipoglikemia, DKA, HHS, krisis tiroid).
2. Melakukan penilaian klinis terfokus pada pasien dengan gangguan metabolik.
3. Menyusun diagnosis kerja dan banding endokrin.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman dan tepat.
5. Memberikan edukasi awal dan rencana tindak lanjut.

Bab 5.1 Prinsip Dasar Endokrin untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Gangguan endokrin sering **diam-diam tapi fatal**.
- Nilai **glukosa darah** lebih awal pada pasien tidak jelas.
- Banyak kegawatan endokrin bersifat **reversibel bila cepat ditangani**.

Kegawatan Endokrin yang Wajib Diingat

- Hipoglikemia
- Diabetic Ketoacidosis (DKA)
- Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS)
- Krisis tiroid
- Insufisiensi adrenal akut

Bab 5.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Dugaan Gangguan Endokrin

Langkah 1 – Primary Survey & Safety

- ABCDE bila tidak stabil
- Cek GDS **segera**

Pasien bingung, kejang, tidak sadar → selalu cek gula darah.

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Endokrin

Pertanyaan Kunci

- Riwayat DM / tiroid / steroid
- Kepatuhan obat (insulin / OHO)
- Asupan makan terakhir
- Gejala poliuria, polidipsia, penurunan BB
- Infeksi / stres pencetus

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Status hidrasi
- Tanda syok
- Napas Kussmaul
- Bau aseton
- Status mental

Bab 5.3 Hipoglikemia

Definisi Klinis

- Gula darah <70 mg/dL dengan gejala.

Gejala

- Adrenergik: keringat dingin, tremor, palpitasi
- Neuroglycopenic: bingung, kejang, penurunan kesadaran

Step-by-Step Tata Laksana Awal

1. Cek GDS
2. Bila sadar → glukosa oral
3. Bila tidak sadar → glukosa IV
4. Evaluasi penyebab

Bab 5.4 Diabetic Ketoacidosis (DKA)

Kriteria Klinis

- Hiperglikemia
- Asidosis metabolik
- Ketonemia/ketonuria

Step-by-Step Pendekatan DKA

1. ABCDE & monitoring
2. Cairan IV
3. Insulin sesuai protokol
4. Koreksi elektrolit
5. Cari faktor pencetus

Bab 5.5 Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS)

Ciri Utama

- Hiperglikemia berat
- Dehidrasi berat
- Tanpa ketoasidosis signifikan

Pendekatan Awal

- Cairan agresif
- Insulin bertahap
- Monitoring ketat

Bab 5.6 Gangguan Tiroid Akut

Krisis Tiroid

- Demam
- Takikardia
- Agitasi

Prinsip Penanganan Awal

- Stabilkan pasien
- Blok sintesis & efek hormon tiroid
- Rujuk / supervisi ketat

Bab 5.7 Insufisiensi Adrenal Akut

Kecurigaan Klinis

- Riwayat steroid lama
- Syok tidak responsif cairan

Tata Laksana Awal

- Cairan IV
- Steroid IV

Bab 5.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pria 25 tahun, DM tipe 1, datang dengan muntah dan sesak

Fokus Roleplay

- Pengenalan DKA (Ketoasidosis Diabetik atau komplikasi metabolisme akut)
- Keamanan tatalaksana awal
- Koordinasi tim

- Edukasi singkat keluarga

Bab 5.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Tidak cek GDS	Miss diagnosis	GDS rutin
Insulin tanpa cairan	Syok	Cairan dulu
Abaikan elektrolit	Aritmia	Monitoring

Sub-Bab 5.10 Checklist Kompetensi Bab 5

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenali kegawatan endokrin
- Melakukan penilaian terfokus
- Menginisiasi terapi awal aman
- Menjelaskan kondisi ke pasien

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **gangguan endokrin sering tidak mencolok namun mematikan**. Kewaspadaan, cek glukosa dini, dan penanganan terstruktur adalah kunci keselamatan pasien.

BAB 6.

GASTROENTEROLOGY (PENYAKIT SALURAN CERNA)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai, memilah kegawatan, dan menangani keluhan saluran cerna** secara sistematis, dengan fokus pada kondisi **akut abdomen dan perdarahan saluran cerna** yang mengancam nyawa.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan pendekatan awal pasien dengan nyeri perut dan keluhan GI.
2. Mengidentifikasi red flags gastrointestinal.
3. Menyusun diagnosis kerja dan banding rasional.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
5. Menentukan indikasi konsultasi bedah dan rujukan.

Bab 6.1 Prinsip Dasar Gastroenterologi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **Nyeri perut adalah diagnosis kerja, bukan diagnosis akhir.**
- Selalu pikirkan kondisi bedah sampai terbukti tidak.
- Perdarahan saluran cerna = kegawatan sampai stabil.

Kondisi Fatal yang Wajib Disingkirkan

- Peritonitis
- Perforasi viskus
- Ileus strangulasi
- Perdarahan saluran cerna masif
- Pankreatitis berat

Bab 6.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Nyeri Perut

Langkah 1 – Penilaian Awal & Stabilitas

- Nilai ABCDE bila nyeri hebat
- Tanda syok
- Status kesadaran

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Nyeri Perut

Pendekatan OPQRST + Lokasi

- Onset (tiba-tiba vs perlahan)

- Provokasi/pereda
- Quality
- Region & radiasi
- Severity
- Time course

Pertanyaan Penting Tambahan

- Muntah (isi, warna)
- BAB & flatus
- Demam
- Riwayat NSAID / alkohol
- Riwayat operasi abdomen

Langkah 3 – Red Flags Nyeri Perut

- Nyeri hebat mendadak
- Abdomen kaku
- Nyeri + syok
- Nyeri pada lansia / anak

Bab 6.3 Pemeriksaan Fisik Abdomen Step-by-Step

Urutan Pemeriksaan

1. Inspeksi
2. Auskultasi
3. Perkusi
4. Palpasi

Temuan Penting

- Defense muscular
- Nyeri tekan lepas
- Distensi
- Bising usus abnormal

Bab 6.4 Perdarahan Saluran Cerna

Klasifikasi

- Upper GI bleeding
- Lower GI bleeding

Tanda Bahaya

- Hematemesis
- Melena
- Hematochezia dengan syok

Pendekatan Awal

1. ABCDE
2. Akses IV besar
3. Cairan / transfusi sesuai indikasi
4. Monitoring ketat

Bab 6.5 Diagnosis Kerja & Banding

Contoh (Nyeri Perut Kanan Bawah)

Diagnosis kerja: Apendisitis akut

Diagnosis banding:

- Gastroenteritis
- Batu ureter
- Ginekologi (wanita)

Bab 6.6 Pemeriksaan Penunjang

Prinsip

- Tidak menunda konsultasi bedah bila indikasi klinis kuat.

Pemeriksaan Umum

- Darah rutin
- Elektrolit
- USG / CT scan sesuai indikasi

Bab 6.7 Tatalaksana Awal Gastrointestinal

Prinsip

- NPO
- Cairan IV
- Analgesia aman
- Antibiotik bila indikasi

Bab 6.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pria 40 tahun, nyeri perut kanan bawah + demam

Fokus Roleplay

- Pengenalan akut abdomen
- Keputusan konsultasi bedah
- Edukasi pasien & keluarga

Bab 6.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Takut beri analgesik	Delay	Analgesia aman
Menunda bedah	Perforasi	Konsul dini
Abaikan red flags	Fatal	Waspada

Bab 6.10 Checklist Kompetensi Bab 6

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai nyeri perut sistematis
- Mengenali akut abdomen
- Menginisiasi terapi awal
- Menentukan indikasi rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **nyeri perut bukan keluhan sepele**. Dokter muda harus selalu berpikir kritis, waspada terhadap kegawatan, dan tidak ragu melibatkan bedah demi keselamatan pasien.

BAB 7.

RENAL MEDICINE & ELECTROLYTES (GINJAL & ELEKTROLIT)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai fungsi ginjal, mengenali kegawatan elektrolit, dan menangani gangguan ginjal akut maupun kronik** secara aman dan sistematis.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Mengenali Acute Kidney Injury (AKI) dan Chronic Kidney Disease (CKD).
2. Mengidentifikasi kegawatan elektrolit (terutama hiperkalemia).
3. Menyusun diagnosis kerja dan banding berbasis etiologi.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
5. Menentukan indikasi konsultasi nefrologi/dialisis.

Bab 7.1 Prinsip Dasar Renal untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **AKI adalah kondisi reversibel bila dikenali dini.**
- Banyak obat umum bersifat nefrotoksik.
- Gangguan elektrolit dapat memicu aritmia fatal.

Kegawatan Renal yang Wajib Diingat

- AKI dengan oliguria/anuria
- Hiperkalemia
- Asidosis metabolik berat
- Overload cairan dengan edema paru

Bab 7.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Gangguan Ginjal

Langkah 1 – Penilaian Awal

- ABCDE bila tidak stabil
- Nilai diuresis (target $\geq 0,5$ ml/kg/jam)
- Review obat terakhir

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Renal

Pertanyaan Kunci

- Penurunan BAK
- Warna urine
- Nyeri pinggang
- Riwayat DM, HTN
- Penggunaan NSAID, ACE-I, herbal

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Status hidrasi
- Edema
- Tanda uremia
- Tekanan darah

Bab 7.3 Klasifikasi AKI

Berdasarkan Etiologi

- Prerenal (hipovolemia, syok)
- Renal intrinsik (ATN, GN)
- Postrenal (obstruksi)

Pendekatan Praktis

- Prerenal paling sering & reversibel

Bab 7.4 Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Utama

- Ureum, kreatinin
- Elektrolit
- Urinalisis
- USG ginjal

Bab 7.5 Hiperkalemia

Definisi Klinis

- Kalium $\geq 5,5$ mmol/L

Tanda Bahaya

- Perubahan EKG
- Kelemahan otot

Step-by-Step Tata Laksana Awal

1. Monitor EKG
2. Stabilkan membran (kalsium)
3. Geser K^+ ke intrasel
4. Eliminasi K^+

Selalu di bawah supervisi & protokol RS.

Bab 7.6 Overload Cairan & Asidosis

Tanda Overload

- Edema paru
- Peningkatan JVP

Prinsip Penanganan

- Batasi cairan
- Diuretik sesuai indikasi
- Pertimbangkan dialisis

Bab 7.7 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pria 65 tahun, DM & HTN, oliguria 2 hari

Fokus Roleplay

- Pengenalan AKI
- Identifikasi prerenal vs renal
- Keputusan terapi cairan
- Komunikasi risiko ke keluarga

Bab 7.8 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Abaikan diuresis	Delay AKI	Monitor ketat
Teruskan NSAID	Perburukan	Stop obat
Tidak cek EKG	Aritmia	EKG wajib

Bab 7.9 Checklist Kompetensi Bab 7

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenali AKI dini

- Menilai status cairan
- Menangani hiperkalemia awal
- Menentukan indikasi rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **ginjal adalah organ sensitif terhadap kesalahan klinis**. Pemantauan diuresis, elektrolit, dan penggunaan obat yang bijak adalah kunci keselamatan pasien.

BAB 8.

HAEMATOLOGY (HEMATOLOGI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai kelainan darah, mengenali kegawatan hematologi, dan menangani kondisi yang berisiko perdarahan, hipoksia jaringan, serta infeksi berat** secara aman dan sistematis.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Mengenali anemia klinis dan menentukan pendekatan awal.
2. Mengidentifikasi kegawatan hematologi (perdarahan aktif, sepsis neutropenik).
3. Menilai gangguan koagulasi secara klinis.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
5. Menentukan indikasi transfusi dan rujukan.

Bab 8.1 Prinsip Dasar Hematologi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Darah adalah sistem transport oksigen, imun, dan hemostasis.
- Perubahan kecil dapat berdampak sistemik besar.
- Transfusi adalah **terapi berisiko**, bukan sekadar angka lab.

Kegawatan Hematologi yang Wajib Diingat

- Anemia berat simptomatik
- Perdarahan aktif
- Trombositopenia berat
- Sepsis neutropenik
- Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

Bab 8.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Dugaan Gangguan Hematologi

Langkah 1 – Penilaian Awal

- ABCDE bila tidak stabil
- Nilai tanda perdarahan
- Tanda hipoksia

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Hematologi

Pertanyaan Kunci

- Lemas, pusing, sesak
- Riwayat perdarahan
- Obat (antikoagulan, kemoterapi)
- Riwayat keganasan
- Demam pada pasien imunokompromais

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Pucat
- Petekie / purpura
- Ekimosis
- Limfadenopati
- Hepatosplenomegali

Bab 8.3 Anemia

Pendekatan Klinis

- Akut vs kronik
- Simptomatik vs asimtomatik

Step-by-Step Penilaian Anemia

1. Nilai stabilitas
2. Tentukan tingkat keparahan
3. Cari tanda perdarahan
4. Tentukan kebutuhan transfuse

Bab 8.4 Indikasi Transfusi Darah

Prinsip

- Treat the patient, not the number.

Indikasi Umum

- Anemia simptomatik
- Hb sangat rendah dengan komorbid
- Perdarahan aktif

Bab 8.5 Gangguan Koagulasi & Trombosit

Kecurigaan Klinis

- Mudah memar
- Perdarahan spontan

Pendekatan Awal

- Hentikan obat pencetus
- Monitoring ketat
- Konsultasi dini

Bab 8.6 Sepsis Neutropenik

Definisi Klinis

- Demam pada pasien dengan neutropenia

Prinsip Penanganan

- Time-critical
- Antibiotik empiris segera

Bab 8.7 Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

Ciri Klinis

- Perdarahan + trombosis
- Penyakit dasar berat

Prinsip Penanganan

- Tangani penyebab
- Supportif

Bab 8.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien kanker dengan demam dan neutropenia

Fokus Roleplay

- Pengenalan sepsis neutropenik
- Kecepatan pemberian antibiotik
- Komunikasi urgensi

Bab 8.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Transfusi hanya karena Hb	Overtransfusi	Nilai klinis
Abaikan petekie	Perdarahan	Waspada
Tunda antibiotik	Mortalitas	Antibiotik cepat

Bab 8.10 Checklist Kompetensi Bab 8

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai anemia klinis
- Mengenali kegawatan hematologi
- Menginisiasi terapi awal aman
- Menentukan indikasi rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **gangguan hematologi sering tersembunyi namun mematikan**. Keputusan transfusi dan penanganan infeksi pada pasien imunokompromais harus cepat, tepat, dan penuh kehati-hatian.

BAB 9.

INFECTIOUS DISEASES (PENYAKIT INFEKSI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali, menilai, dan menangani penyakit infeksi** dengan fokus pada **sepsis dan infeksi yang mengancam nyawa**, serta penerapan prinsip penggunaan antibiotik yang rasional.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Mengenali tanda dan kriteria sepsis secara dini.
2. Melakukan penilaian sumber infeksi secara sistematis.
3. Menginisiasi tatalaksana awal sepsis (golden hour).
4. Menggunakan antibiotik empiris secara rasional.
5. Melakukan komunikasi dan pencegahan infeksi.

Bab 9.1 Prinsip Dasar Penyakit Infeksi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Infeksi adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di RS.
- **Sepsis adalah kegawatan time-critical.**
- Antibiotik adalah obat penyelamat sekaligus berisiko bila tidak rasional.

Infeksi Gawat yang Wajib Diingat

- Sepsis / septic shock
- Pneumonia berat
- Meningitis
- Infeksi jaringan lunak nekrotikan
- TB berat / diseminata

Bab 9.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Dugaan Infeksi

Langkah 1 – Penilaian Awal & Stabilitas

- ABCDE
- Nilai tanda vital lengkap
- Identifikasi tanda syok

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Infeksi

Pertanyaan Kunci

- Demam / hipotermia
- Fokus infeksi (batuk, BAK, luka)
- Onset dan progresivitas
- Riwayat rawat inap / antibiotik
- Komorbid & imunosupresi

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Status mental
- Kulit & jaringan lunak
- Paru
- Abdomen
- Luka / akses invasif

Bab 9.3 Sepsis

Definisi Klinis

- Disfungsi organ akibat respons tubuh terhadap infeksi.

Tanda Klinis Penting

- Perubahan kesadaran
- Hipotensi
- Takipnea
- Oliguria

Bab 9.4 Step-by-Step Tata Laksana Awal Sepsis (Golden Hour)

1. Identifikasi sepsis dini
2. Oksigen bila perlu
3. Akses IV besar
4. Cairan resusitasi
5. Antibiotik empiris segera
6. Monitoring ketat

Bab 9.5 Pemilihan Antibiotik Empiris

Prinsip

- Berdasarkan sumber infeksi
- Sesuaikan dengan pola kuman lokal
- De-eskalasi bila data tersedia

Bab 9.6 Tuberkulosis (TB)

Kecurigaan Klinis

- Batuk >2 minggu
- BB turun
- Keringat malam

Peran Dokter Muda

- Skrining
- Edukasi
- Rujukan sesuai program nasional

Bab 9.7 Infeksi HIV & Oportunistik

Prinsip Pendekatan

- Kerahasiaan
- Non-diskriminatif
- Penilaian infeksi oportunistik

Bab 9.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pria 60 tahun, demam, hipotensi, penurunan kesadaran

Fokus Roleplay

- Pengenalan sepsis
- Kecepatan tindakan
- Pemilihan antibiotik awal
- Komunikasi keluarga

Bab 9.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Menunda antibiotik	Mortalitas	Antibiotik dini
Fokus lab saja	Delay	Klinik utama
Antibiotik tidak tepat	Resistensi	Rasional

Bab 9.10 Checklist Kompetensi Bab 9

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenali sepsis dini
- Menginisiasi tatalaksana golden hour
- Memilih antibiotik empiris rasional
- Menjelaskan kondisi ke keluarga

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **infeksi, khususnya sepsis, adalah perlombaan melawan waktu**. Kecepatan, ketepatan antibiotik, dan pemantauan ketat menentukan keselamatan pasien.

BAB 10.

NEUROLOGY (NEUROLOGI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali kegawatan neurologi, menilai fungsi saraf secara cepat dan sistematis, serta menginisiasi tata laksana awal yang tepat** pada kondisi yang mengancam nyawa dan fungsi.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian neurologis cepat dan terstruktur.
2. Mengenali stroke akut dan menentukan prioritas rujukan.
3. Menangani kejang dan penurunan kesadaran awal.
4. Menilai nyeri kepala berbahaya.
5. Melakukan komunikasi klinis yang aman pada kasus neurologi.

Bab 10.1 Prinsip Dasar Neurologi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Neurologi menuntut **kecepatan + ketepatan pemeriksaan**.
- Defisit neurologis sering irreversibel bila terlambat.
- Status mental adalah vital sign ke-6.

Kegawatan Neurologi yang Wajib Diingat

- Stroke akut
- Kejang berulang / status epileptikus
- Penurunan kesadaran
- Meningitis / ensefalitis
- Cedera kepala berat

Bab 10.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Masalah Neurologi

Langkah 1 – Stabilitas Awal

- ABCDE
- Proteksi jalan napas
- Cek glukosa darah

Langkah 2 – Penilaian Kesadaran

Glasgow Coma Scale (GCS)

- Eye (E)
- Verbal (V)
- Motor (M)

GCS ≤ 8 = pertimbangkan proteksi jalan napas

Langkah 3 – Pemeriksaan Neurologis Singkat

- Status mental
- Saraf kranialis
- Motorik
- Sensorik
- Tanda lateralisasi

Bab 10.3 Stroke Akut

Kecurigaan Klinis

- FAST (Face, Arm, Speech, Time)

Prinsip Penanganan Awal

- Time is brain
- CT-scan segera
- Jangan tunda rujukan

Bab 10.4 Kejang

Pendekatan Awal

- Lindungi pasien
- Cek gula
- Hentikan kejang

Status Epileptikus

- Kejang >5 menit
- Kegawatan medis

Bab 10.5 Penurunan Kesadaran

Pendekatan Diferensial

- Metabolik
- Struktural
- Infeksi

Prinsip

- Anggap hipoglikemia sampai terbukti sebaliknya

Bab 10.6 Nyeri Kepala

Red Flags

- Onset mendadak
- Disertai defisit
- Demam & kaku kuduk

Bab 10.7 Meningitis & Ensefalitis

Tanda Klinis

- Demam
- Nyeri kepala
- Penurunan kesadaran

Prinsip Penanganan

- Antibiotik/antivirus dini
- Jangan tunda terapi

Bab 10.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien datang mendadak bicara pelo dan hemiparesis

Fokus Roleplay

- Pengenalan stroke
- Penilaian FAST
- Edukasi keluarga

Bab 10.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Tidak cek GDS	Delay	Cek awal
Pemeriksaan lama	Time loss	Fokus
Tunda rujukan	Defisit	Rujuk cepat

Bab 10.10 Checklist Kompetensi Bab 10

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai GCS dengan benar
- Mengenali stroke & kejang
- Menginisiasi tatalaksana awal
- Berkomunikasi efektif

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **keterlambatan dalam kasus neurologi berarti kehilangan fungsi**. Pemeriksaan cepat, fokus, dan pengambilan keputusan tepat waktu adalah kunci utama keselamatan pasien.

BAB 11.

MUSCULOSKELETAL & RHEUMATOLOGY (MUSKULOSKELETAL & REUMATOLOGI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai keluhan nyeri muskuloskeletal, mengenali kegawatan sendi dan jaringan lunak, serta membedakan kondisi inflamasi, degeneratif, dan infeksi** secara sistematis dan aman.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian nyeri dan fungsi muskuloskeletal.
2. Mengenali red flags nyeri sendi dan tulang.
3. Membedakan nyeri mekanik vs inflamasi.
4. Mengenali septic arthritis dan kegawatan MSK.
5. Menginisiasi tatalaksana awal dan rujukan tepat.

Bab 11.1 Prinsip Dasar MSK & Reumatologi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Nyeri sendi adalah keluhan umum namun bisa fatal bila infeksi.
- Jangan melewatkan **septic arthritis**.
- Fungsi lebih penting dari sekadar nyeri.

Kegawatan MSK yang Wajib Diingat

- Septic arthritis
- Osteomyelitis
- Fraktur terbuka
- Kompartemen sindrom
- Nyeri punggung dengan defisit neurologis

Bab 11.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Keluhan MSK

Langkah 1 – Penilaian Awal

- ABCDE bila trauma/infeksi berat
- Nilai nyeri dan fungsi
- Cari tanda infeksi

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus MSK

Pertanyaan Kunci

- Onset (akut/kronik)
- Lokasi dan jumlah sendi
- Kekakuan pagi
- Trauma
- Demam
- Riwayat gout, autoimun

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Inspeksi (bengkak, kemerahan)
- Palpasi (hangat, nyeri tekan)
- Range of motion
- Bandingkan sisi kontralateral

Bab 11.3 Nyeri Sendi: Mekanik vs Inflamasi

Mekanik

- Nyeri bertambah saat aktivitas
- Kekakuan pagi singkat

Inflamasi

- Nyeri istirahat
- Kekakuan pagi >30 menit
- Bengkak & hangat

Bab 11.4 Septic Arthritis

Kecurigaan Klinis

- Nyeri sendi akut
- Bengkak, hangat
- Demam

Prinsip Penanganan

- Jangan ditunda
- Antibiotik IV dini

- Rujukan segera

Bab 11.5 Gout & Pseudogout

Gout

- Nyeri akut hebat
- Sendi MTP I

Prinsip Awal

- Kontrol nyeri
- Edukasi diet

Bab 11.6 Nyeri Punggung

Red Flags

- Demam
- Trauma
- Defisit neurologis
- Inkontinensia

Bab 11.7 Penyakit Reumatik Umum

Contoh

- Rheumatoid arthritis
- Lupus

Peran Dokter Muda

- Skrining
- Monitoring
- Rujukan

Bab 11.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Nyeri lutut akut, bengkak, demam

Fokus Roleplay

- Bedakan gout vs septic arthritis
- Keputusan rujukan cepat

Bab 11.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Anggap gout semua	Delay infeksi	Curiga septic
Tidak nilai fungsi	Miss defisit	Uji ROM
Tunda rujukan	Kerusakan	Rujuk cepat

Bab 11.10 Checklist Kompetensi Bab 11

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai nyeri MSK sistematis
- Mengenali red flags
- Menginisiasi tatalaksana awal
- Menentukan rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **nyeri muskuloskeletal bukan selalu masalah ringan**. Infeksi sendi dan kondisi berbahaya harus dikenali cepat untuk mencegah kecacatan permanen.

BAB 12.

DERMATOLOGY (DERMATOLOGI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai kelainan kulit secara sistematis, mengenali manifestasi penyakit sistemik pada kulit, serta mengidentifikasi kegawatan dermatologi** yang memerlukan penanganan segera atau rujukan cepat.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan pendekatan deskriptif lesi kulit.
2. Mengenali red flags pada kelainan kulit.
3. Mengidentifikasi kegawatan dermatologi.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
5. Memberikan edukasi dasar kepada pasien.

Bab 12.1 Prinsip Dasar Dermatologi untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Kulit adalah **cermin penyakit sistemik**.
- Deskripsi lesi yang baik = setengah diagnosis.
- Jangan meremehkan ruam disertai gejala sistemik.

Kegawatan Dermatologi yang Wajib Diingat

- Stevens-Johnson Syndrome (SJS) / TEN
- Anafilaksis kulit (urtikaria + syok)
- Necrotizing fasciitis
- Selulitis berat
- Reaksi obat berat

Bab 12.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien dengan Kelainan Kulit

Langkah 1 – Penilaian Awal

- Nilai stabilitas (ABCDE bila perlu)
- Cari tanda sistemik (demam, hipotensi)
- Riwayat obat terbaru

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Dermatologi

Pertanyaan Kunci

- Onset & progresi
- Gatal atau nyeri
- Distribusi lesi
- Paparan (obat, infeksi, alergi)
- Riwayat penyakit sistemik

Langkah 3 – Deskripsi Lesi Kulit

- Lokasi
- Jumlah
- Ukuran
- Warna
- Bentuk
- Batas
- Permukaan

Bab 12.3 Lesi Primer & Sekunder**Lesi Primer**

- Makula
- Papula
- Vesikel
- Pustula

Lesi Sekunder

- Krusta
- Ulkus
- Skar

Bab 12.4 Ruam Akut**Pendekatan**

- Infeksi
- Alergi

- Obat

Red Flags

- Demam tinggi
- Mukosa terlibat
- Nyeri hebat

Bab 12.5 Stevens-Johnson Syndrome (SJS)

Kecurigaan Klinis

- Riwayat obat
- Lesi target
- Mukositis

Prinsip Penanganan

- Hentikan obat
- Rawat intensif
- Rujukan segera

Bab 12.6 Infeksi Kulit & Jaringan Lunak

Selulitis

- Nyeri, merah, hangat

Necrotizing Fasciitis

- Nyeri hebat tidak sesuai tampilan

Bab 12.7 Penyakit Kulit Umum

Contoh

- Dermatitis
- Psoriasis
- Infeksi jamur

Peran Dokter Muda

- Diagnosis awal
- Terapi dasar
- Edukasi

Bab 12.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Ruam luas setelah konsumsi obat

Fokus Roleplay

- Identifikasi SJS
- Hentikan obat
- Komunikasi urgensi

Bab 12.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Tidak deskripsi lesi	Salah diagnosis	Deskripsi sistematis
Abaikan mukosa	Miss SJS	Periksa lengkap
Anggap alergi biasa	Delay	Waspada red flag

Bab 12.10 Checklist Kompetensi Bab 12

Peserta kompeten bila mampu:

- Mendeskripsikan lesi kulit
- Mengenali red flags
- Menginisiasi terapi awal
- Menentukan rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **kelainan kulit sering menjadi petunjuk awal penyakit berat**. Pendekatan sistematis dan kewaspadaan terhadap red flags adalah kunci keselamatan pasien.

BAB 13.

PALLIATIVE CARE, ETHICS & END-OF-LIFE CARE

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **memberikan perawatan yang berfokus pada kualitas hidup, mengambil keputusan etis klinis, serta melakukan komunikasi yang empatik dan profesional** pada pasien dengan penyakit terminal atau kondisi yang mengancam nyawa.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Memahami prinsip dasar perawatan paliatif.
2. Mengenali pasien yang membutuhkan pendekatan paliatif.
3. Mengelola gejala utama (nyeri, sesak, cemas).
4. Mengambil keputusan etis klinis secara bertanggung jawab.
5. Melakukan komunikasi akhir hayat dengan pasien dan keluarga.

Bab 13.1 Prinsip Dasar Palliative Care untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Paliatif **bukan berarti menyerah**.
- Fokus utama adalah kualitas hidup pasien.
- Dapat diberikan bersamaan dengan terapi kuratif.

Kapan Memikirkan Paliatif

- Penyakit terminal
- Gagal organ stadium akhir
- Kanker stadium lanjut
- Gejala berat yang sulit dikontrol

Bab 13.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Paliatif

Langkah 1 – Identifikasi Pasien

- Penyakit progresif
- Prognosis buruk
- Penurunan fungsi signifikan

Langkah 2 – Penilaian Holistik

- Fisik
- Psikologis
- Sosial
- Spiritual

Langkah 3 – Penentuan Tujuan Perawatan

- Diskusi harapan pasien
- Nilai preferensi keluarga
- Tentukan goals of care

Bab 13.3 Manajemen Gejala Umum

Nyeri

- Penilaian nyeri
- Analgesik bertahap

Sesak Napas

- Oksigen sesuai kebutuhan
- Posisi nyaman

Cemas & Delirium

- Pendekatan non-farmakologis
- Obat bila perlu

Bab 13.4 Komunikasi Sulit & Bad News

Prinsip Komunikasi

- Jujur
- Empatik
- Bertahap

Kerangka Praktis

- Persiapan
- Penyampaian
- Respons emosi

- Rencana lanjut

Bab 13.5 Etika Klinis Dasar

Prinsip Etika

- Autonomi
- Beneficence
- Non-maleficence
- Justice

Bab 13.6 Do Not Resuscitate (DNR) & Keputusan Akhir Hayat

Prinsip

- Berdasarkan kondisi medis
- Diskusi terbuka
- Dokumentasi jelas

Bab 13.7 Peran Dokter Muda atau Co.Ass dalam Tim Paliatif

- Monitoring gejala
- Edukasi keluarga
- Koordinasi tim

Bab 13.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien kanker stadium akhir dengan sesak berat

Fokus Roleplay

- Diskusi tujuan perawatan
- Kontrol gejala
- Komunikasi empatik

Bab 13.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Dampak	Koreksi
Menghindari pembicaraan	Konflik	Komunikasi dini
Fokus kuratif saja	Penderitaan	Paliatif dini
Bahasa medis rumit	Salah paham	Bahasa awam

Bab 13.10 Checklist Kompetensi Bab 13

Peserta kompeten bila mampu:

- Mengenal pasien paliatif
- Mengelola gejala dasar
- Berkomunikasi empatik
- Memahami prinsip etika

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **menjadi dokter bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menemani pasien dengan bermartabat**. Keputusan etis dan komunikasi yang baik adalah kompetensi klinis utama.

BAB 14.

PSYCHIATRY (PSIKIATRI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali gangguan psikiatri yang sering ditemui di IGD dan bangsal**, melakukan penilaian status mental secara sistematis, menangani kegawatan psikiatri, serta berkomunikasi aman dan empatik dengan pasien dan keluarga.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan Mental Status Examination (MSE) sederhana.
2. Mengenali kegawatan psikiatri (agitasi, bunuh diri, psikosis akut).
3. Melakukan pendekatan awal pasien dengan gangguan jiwa.
4. Menentukan kebutuhan rujukan dan pengamanan pasien.
5. Berkomunikasi non-stigmatis dan profesional.

Bab 14.1 Prinsip Dasar Psikiatri untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Gangguan jiwa adalah **penyakit medis**, bukan masalah kemauan.
- Keselamatan pasien dan lingkungan adalah prioritas utama.
- Komunikasi lebih penting daripada obat pada fase awal.

Kegawatan Psikiatri yang Wajib Diingat

- Risiko bunuh diri
- Agitasi berat / agresivitas
- Psikosis akut
- Delirium (rujuk Bab Neurologi & Geriatri)

Bab 14.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Psikiatri

Langkah 1 – Keamanan

- Amankan lingkungan
- Jangan biarkan pasien sendirian
- Libatkan keluarga/petugas

Langkah 2 – Penilaian Medis Dasar

- ABCDE bila perlu
- Cek glukosa darah
- Singkirkan penyebab organik

Langkah 3 – Mental Status Examination (MSE)

- Penampilan & perilaku
- Mood & afek
- Proses pikir
- Isi pikir
- Persepsi
- Insight & judgement

Bab 14.3 Risiko Bunuh Diri

Faktor Risiko

- Riwayat percobaan
- Depresi berat
- Psikosis
- Penyalahgunaan zat

Prinsip Penanganan

- Tanyakan langsung
- Jangan menghakimi
- Amankan pasien

Bab 14.4 Agitasi & Perilaku Agresif

Pendekatan Awal

- De-eskalasi verbal
- Lingkungan tenang

Bila Gagal

- Farmakologis sesuai protokol
- Pengamanan fisik terakhir

Bab 14.5 Psikosis Akut

Kecurigaan Klinis

- Halusinasi
- Waham
- Perilaku tidak terorganisir

Prinsip

- Nilai risiko
- Singkirkan sebab medis
- Rujukan psikiatri

Bab 14.6 Depresi & Gangguan Cemas

Tanda Bahaya

- Ide bunuh diri
- Penarikan sosial berat

Peran Dokter Muda

- Skrining awal
- Edukasi
- Rujukan

Bab 14.7 Penyalahgunaan Zat

Pendekatan

- Non-judgemental
- Kenali intoksikasi & putus zat

Bab 14.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien gelisah, bicara tidak terarah, menolak perawatan

Fokus Roleplay

- Keamanan
- De-eskalasi
- Penilaian risiko

Bab 14.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Dampak	Koreksi
Menghindari pasien	Eskalasi	Hadapi empatik
Tidak tanya bunuh diri	Miss risiko	Tanya langsung
Stigmatisasi	Konflik	Bahasa netral

Bab 14.10 Checklist Kompetensi Bab 14

Peserta kompeten bila mampu:

- Melakukan MSE dasar
- Mengenali kegawatan psikiatri
- Menjaga keamanan pasien
- Berkomunikasi empatik

RINGKASAN

Bab ini menegaskan bahwa **dokter dari semua disiplin wajib mampu menangani masalah psikiatri dasar**. Keselamatan, empati, dan struktur berpikir klinis adalah kunci.

BAB 15.

OPHTHALMOLOGY & ENT (MATA, THT)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai keluhan mata dan THT secara cepat dan aman**, mengenali kegawatan yang mengancam penglihatan, jalan napas, dan pendengaran, serta menentukan tatalaksana awal dan indikasi rujukan segera.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan pemeriksaan dasar mata dan THT.
2. Mengenali kegawatan oftalmologi dan THT.
3. Menginisiasi tatalaksana awal yang aman.
4. Menentukan indikasi rujukan segera.
5. Berkomunikasi efektif dengan pasien.

Bab 15.1 Prinsip Dasar Ophthalmology & ENT untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- Gangguan mata dapat menyebabkan **kebutaan permanen bila terlambat**.
- Masalah THT dapat menjadi **kegawatan jalan napas**.
- Jangan menunda rujukan bila ada red flags.

Kegawatan Mata & THT yang Wajib Diingat

- Penurunan penglihatan akut
- Trauma mata
- Sudden hearing loss
- Epistaksis masif
- Obstruksi jalan napas atas

Bab 15.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Mata & THT

Langkah 1 – Penilaian Awal

- ABCDE bila ada gangguan napas/perdarahan
- Nilai nyeri & fungsi
- Tentukan unilateral/bilateral

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus

Pertanyaan Kunci Mata

- Onset penurunan penglihatan
- Nyeri mata
- Trauma
- Mata merah

Pertanyaan Kunci THT

- Nyeri telinga
- Gangguan dengar
- Mimisan
- Nyeri tenggorok

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Dasar

Mata

- Visus
- Inspeksi
- Gerak bola mata
- Refleks cahaya

THT

- Otoskopi
- Inspeksi hidung
- Orofaring

Bab 15.3 Kegawatan Oftalmologi

Penurunan Penglihatan Akut

- Anggap gawat sampai terbukti sebaliknya

Trauma Mata

- Jangan tekan bola mata
- Lindungi mata
- Rujukan segera

Bab 15.4 Mata Merah

Pendekatan Klinis

- Nyeri + penurunan visus = gawat
- Tanpa nyeri = sering jinak

Bab 15.5 Kegawatan THT

Epistaksis

- Tekan anterior
- Evaluasi stabilitas

Obstruksi Jalan Napas Atas

- Stridor
- Drooling
- Distres napas

Bab 15.6 Sudden Hearing Loss

Prinsip

- Anggap kegawatan
- Rujukan segera

Bab 15.7 Penyakit Mata & THT Umum

Mata

- Konjungtivitis
- Hordeolum

THT

- Otitis
- Faringitis

Bab 15.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien mata merah nyeri hebat dan penglihatan menurun

Fokus Roleplay

- Identifikasi red flags
- Keputusan rujukan cepat

Bab 15.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Tidak cek visus	Miss gawat	Cek awal

Anggap konjungtivitis Delay Cari red flags

Tunda rujukan Kebutaan Rujuk cepat

Bab 15.10 Checklist Kompetensi Bab 15

Peserta kompeten bila mampu:

- Pemeriksaan dasar mata & THT
- Mengenali kegawatan
- Menginisiasi tindakan awal
- Menentukan rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **masalah mata dan THT sering tampak ringan namun dapat berakibat fatal bila terlambat**. Pemeriksaan sederhana, kewaspadaan red flags, dan rujukan tepat waktu adalah kunci utama.

BAB 16.

OBSTETRICS & GYNECOLOGY (OBSTETRI & GINEKOLOGI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai keluhan obstetri dan ginekologi yang sering ditemui di IGD dan bangsal**, mengenali kegawatan ibu hamil dan non-hamil, serta melakukan tatalaksana awal yang aman dan tepat waktu.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian awal pasien obstetri dan ginekologi.
2. Mengenali kegawatan obstetri yang mengancam nyawa ibu.
3. Mengenali kegawatan ginekologi non-hamil.
4. Menginisiasi tatalaksana awal dan rujukan segera.
5. Berkomunikasi empatik terkait isu reproduksi.

Bab 16.1 Prinsip Dasar Obgin untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **Dua nyawa dalam satu pasien** pada kehamilan.
- Perdarahan pada wanita usia reproduktif = anggap gawat.
- Keputusan cepat menyelamatkan ibu.

Kegawatan Obgin yang Wajib Diingat

- Perdarahan antepartum/postpartum
- Preeklamsia/eklamsia
- Kehamilan ektopik
- Abortus inkomplet
- Sepsis obstetri

Bab 16.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Obgin

Langkah 1 – Penilaian Awal

- ABCDE
- Nilai perdarahan
- Tentukan status kehamilan

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Obgin

Pertanyaan Kunci

- HPHT & usia kehamilan
- Nyeri perut bawah
- Perdarahan pervaginam
- Riwayat obstetri
- Kontraksi / cairan ketuban

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Tanda vital
- Pemeriksaan abdomen
- Pemeriksaan obstetri luar

Pemeriksaan dalam **hanya bila aman & di bawah supervisi.**

Bab 16.3 Perdarahan pada Kehamilan

Prinsip

- Stabilkan ibu terlebih dahulu

Red Flags

- Perdarahan banyak
- Syok
- Nyeri hebat

Bab 16.4 Preeklamsia & Eklamsia

Kecurigaan Klinis

- Hipertensi
- Proteinuria
- Sakit kepala hebat

Prinsip Penanganan Awal

- Kontrol tekanan darah
- Pencegahan kejang
- Rujukan segera

Bab 16.5 Kehamilan Ektopik

Kecurigaan Klinis

- Nyeri perut
- Amenore
- Perdarahan

Prinsip

- Anggap ruptur sampai terbukti sebaliknya

Bab 16.6 Abortus

Jenis

- Imminens
- Inkomplet

Peran Dokter Muda

- Stabilkan
- Edukasi
- Rujukan

Bab 16.7 Kegawatan Ginekologi Non-Hamil

Contoh

- Torsio ovarium
- PID berat

Bab 16.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Wanita usia subur dengan nyeri perut dan perdarahan

Fokus Roleplay

- Tentukan status kehamilan
- Curiga ektopik
- Keputusan rujukan cepat

Bab 16.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Fokus janin dulu	Ibu syok	Ibu prioritas
Tunda rujukan	Mortalitas	Rujuk cepat
Tidak tanya HPHT	Salah arah	Anamnesis lengkap

Bab 16.10 Checklist Kompetensi Bab 16

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai pasien obgin akut
- Mengenali kegawatan
- Menginisiasi tindakan awal
- Berkomunikasi empatik

RINGKASAN

Bab ini menegaskan bahwa **kegawatan obstetri dan ginekologi adalah kondisi waktu-kritis**. Keselamatan ibu adalah prioritas utama, dan keputusan cepat menyelamatkan nyawa.

BAB 17.

PEDIATRICS (PEDIATRI)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menilai dan menangani pasien anak secara aman**, mengenali kegawatan pediatri yang sering ditemui di IGD dan bangsal, serta berkomunikasi efektif dengan anak dan orang tua.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian awal anak secara sistematis.
2. Mengenali kegawatan pediatri yang mengancam nyawa.
3. Menginisiasi tatalaksana awal yang tepat sesuai usia.
4. Menilai status gizi dan tumbuh kembang dasar.
5. Berkomunikasi empatik dengan orang tua/wali.

Bab 17.1 Prinsip Dasar Pediatri untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **Anak bukan dewasa kecil** (fisiologi & dosis berbeda).
- Perubahan kondisi bisa sangat cepat.
- Orang tua adalah bagian dari tim perawatan.

Kegawatan Pediatri yang Wajib Diingat

- Distres napas
- Dehidrasi berat
- Kejang demam
- Sepsis neonatus/anak
- Syok (hipovolemik/septik)

Bab 17.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Anak

Langkah 1 – Penilaian Awal (ABCDE Pediatri)

- Airway (posisi & patensi)
- Breathing (RR, retraksi)
- Circulation (CRT, nadi)
- Disability (AVPU)

- Exposure (ruam, trauma)

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus Pediatri

Pertanyaan Kunci

- Usia & berat badan
- Onset keluhan
- Asupan cairan/BAK
- Riwayat kejang/demam
- Imunisasi

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Tanda distress napas
- Status hidrasi
- Status nutrisi
- Tanda infeksi

Bab 17.3 Distres Napas pada Anak

Tanda Bahaya

- Retraksi
- Stridor/wheezing berat
- Sianosis

Prinsip Penanganan

- Oksigen sesuai kebutuhan
- Jangan tunda rujukan

Bab 17.4 Dehidrasi

Penilaian Klinis

- Ringan
- Sedang
- Berat

Prinsip

- Oral rehydration bila memungkinkan
- IV bila berat

Bab 17.5 Kejang Demam

Prinsip

- Umumnya jinak
- Lindungi jalan napas
- Edukasi orang tua

Bab 17.6 Sepsis & Syok pada Anak

Kecurigaan Klinis

- Letargi
- Takikardia
- Perfusi buruk

Prinsip

- Time-critical
- Resusitasi dini

Bab 17.7 Neonatus

Kegawatan Umum

- Sepsis neonatus
- Ikterus berat

Peran Dokter Muda

- Deteksi dini
- Rujukan cepat

Bab 17.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Balita demam tinggi, napas cepat, tampak lemas

Fokus Roleplay

- Penilaian ABCDE pediatri
- Curiga sepsis
- Komunikasi dengan orang tua

Bab 17.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Salah dosis obat	Toksisitas	Hitung BB
Abaikan orang tua	Konflik	Libatkan
Tunda rujukan	Perburukan	Rujuk cepat

Bab 17.10 Checklist Kompetensi Bab 17

Peserta kompeten bila mampu:

- Menilai anak dengan ABCDE
- Mengenali kegawatan
- Menghitung dosis obat
- Berkomunikasi efektif

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **penanganan anak membutuhkan kewaspadaan tinggi, dosis tepat, dan komunikasi yang baik**. Keputusan cepat dan aman menyelamatkan nyawa dan masa depan anak.

BAB 18.

EMERGENCY & TRAUMA (GAWAT DARURAT & TRAUMA)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **menangani pasien gawat darurat dan trauma secara cepat, terstruktur, dan aman**, dengan fokus pada **pendekatan ABCDE, resusitasi awal, dan pengambilan keputusan time-critical**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan primary survey ABCDE secara benar.
2. Menginisiasi resusitasi awal pada pasien gawat.
3. Mengenali dan menangani trauma utama.
4. Melakukan secondary survey terarah.
5. Berkomunikasi efektif dalam tim emergensi.

Bab 18.1 Prinsip Dasar Emergency & Trauma untuk Dokter Muda

Inti Konsep

- **Treat first what kills first.**
- Waktu adalah faktor penentu luaran.
- Tindakan sederhana yang cepat sering menyelamatkan nyawa.

Kegawatan Trauma yang Wajib Diingat

- Obstruksi jalan napas
- Perdarahan masif
- Tension pneumothorax
- Cedera kepala berat
- Syok

Bab 18.2 Step-by-Step Primary Survey (ABCDE)

A – Airway dengan Proteksi Cervical Spine

- Nilai patensi jalan napas
- Stabilisasi tulang leher
- Suction bila perlu

B – Breathing

- Nilai RR, simetri, suara napas
- Beri oksigen
- Tangani pneumothorax segera

C – Circulation & Control of Bleeding

- Nilai nadi & tekanan darah
- Kontrol perdarahan eksternal
- Akses IV besar & cairan

D – Disability

- Nilai GCS
- Cek glukosa darah
- Nilai lateralisasi

E – Exposure & Environment

- Buka pakaian pasien
- Cegah hipotermia

Bab 18.3 Resusitasi Cairan & Syok**Klasifikasi Syok**

- Hipovolemik
- Septik
- Kardiogenik

Prinsip Resusitasi

- Identifikasi jenis syok
- Resusitasi dini

Bab 18.4 Trauma Kepala**Penilaian Awal**

- GCS
- Tanda fraktur

Red Flags

- Penurunan kesadaran
- Muntah berulang

Bab 18.5 Trauma Thoraks

Kegawatan Utama

- Tension pneumothorax
- Hemothorax masif

Prinsip

- Jangan tunda tindakan penyelamat

Bab 18.6 Trauma Abdomen

Kecurigaan Klinis

- Nyeri tekan
- Distensi

Prinsip

- Anggap perdarahan sampai terbukti sebaliknya

Bab 18.7 Secondary Survey

- Anamnesis singkat (AMPLE)
- Pemeriksaan head-to-toe

Bab 18.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Korban kecelakaan lalu lintas, tidak sadar

Fokus Roleplay

- Primary survey ABCDE
- Identifikasi perdarahan
- Koordinasi tim

Bab 18.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Lompat ke diagnosis	Delay	Ikuti ABCDE
Tunda kontrol perdarahan	Syok	Kontrol cepat
Lupa hipotermia	Koagulopati	Cegah

Bab 18.10 Checklist Kompetensi Bab 18

Peserta kompeten bila mampu:

- Melakukan ABCDE tanpa ragu
- Menginisiasi resusitasi
- Mengenali trauma gawat
- Bekerja dalam tim

RINGKASAN

Bab ini menegaskan bahwa **emergency dan trauma adalah inti keterampilan dokter jaga**. Pendekatan sistematis, kecepatan, dan kerja tim menentukan hidup-mati pasien.

BAB 19.

TOXICOLOGY & POISONING (KERACUNAN)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda kemampuan **mengenali, menilai, dan menangani pasien keracunan secara cepat dan aman**, dengan fokus pada **stabilisasi awal, identifikasi toksin, dan pencegahan komplikasi fatal**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan penilaian awal pasien keracunan.
2. Menstabilkan ABCDE pada kasus toksikologi.
3. Mengidentifikasi toksidrom utama.
4. Menginisiasi tatalaksana awal yang tepat.
5. Menentukan kebutuhan rujukan.

Bab 19.1 Prinsip Dasar Toksikologi untuk Dokter Jaga

Inti Konsep

- **ABCDE selalu prioritas sebelum antidot.**
- Waktu paparan sangat menentukan luaran.
- Tidak semua keracunan membutuhkan antidot.

Jalur Paparan Umum

- Oral
- Inhalasi
- Injeksi
- Kontak kulit

Bab 19.2 Step-by-Step Pendekatan Pasien Keracunan

Langkah 1 – Stabilisasi Awal (ABCDE)

- Amankan jalan napas
- Oksigen bila perlu
- Akses IV dan monitoring

Langkah 2 – Anamnesis Terfokus (AMPLE-T)

T (Toxin): jenis, jumlah, waktu paparan

Langkah 3 – Pemeriksaan Fisik Terarah

- Status mental
- Pupil
- Tanda vital
- Bau khas

Sub-Bab 19.3 Toksidrom Penting

Toksidrom	Ciri Utama
Opioid	Miosis, depresi napas
Kolinergik	SLUDGE
Antikolinergik	Panas, delirium
Simpatomimetik	Takikardia, agitasi

Bab 19.4 Dekontaminasi

Prinsip

- Jangan rutin
- Pertimbangkan waktu & risiko aspirasi

Metode

- Karbon aktif
- Irigasi kulit

Bab 19.5 Antidot Penting

Toksin	Antidot
Opioid	Nalokson
Organofosfat	Atropin, pralidoksim
Benzodiazepin	Flumazenil (selektif)

Bab 19.6 Keracunan Spesifik Umum

Paracetamol

- Risiko hepatotoksik
- Perlu penilaian dini

Pestisida

- Sangat mematikan
- Perlindungan diri petugas

Bab 19.7 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien ditemukan tidak sadar dengan botol obat

Fokus Roleplay

- ABCDE
- Identifikasi toksidrom
- Keputusan antidot

Bab 19.8 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan Risiko Koreksi

Fokus antidot dulu Fatal ABCDE dulu

Asumsi satu toksin Miss Evaluasi luas

Lupa proteksi diri Paparan APD

Bab 19.9 Checklist Kompetensi Bab 19

Peserta kompeten bila mampu:

- Menstabilkan pasien keracunan
- Mengenali toksidrom
- Memberi antidot tepat
- Menentukan rujukan

RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa **penanganan keracunan adalah lomba dengan waktu.**

Pendekatan sistematis, proteksi diri, dan keputusan tepat menyelamatkan nyawa.

BAB 20.

CLINICAL SKILLS & PROCEDURES (KETERAMPILAN KLINIS & TINDAKAN)

Tujuan Bab

Membekali dokter muda dengan **keterampilan klinis inti yang wajib dikuasai saat jaga**, mencakup tindakan diagnostik dan terapeutik dasar yang **sering muncul di OSCE, IGD, dan bangsal**.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta mampu:

1. Melakukan prosedur klinis dasar secara aman.
2. Mengetahui indikasi, kontraindikasi, dan komplikasi tindakan.
3. Menyiapkan alat dan pasien dengan benar.
4. Melakukan informed consent sederhana.
5. Mengenali kapan harus menghentikan tindakan dan merujuk.

Bab 20.1 Prinsip Umum Tindakan Klinis

Inti Konsep

- **Safety first (pasien & operator).**
- Asepsis dan antisepsis wajib.
- Kenali batas kompetensi.

Checklist Universal Sebelum Tindakan

- Identitas pasien
- Indikasi jelas
- Informed consent
- Alat lengkap
- Monitoring tersedia

Bab 20.2 Venipuncture & Pemasangan Infus

Indikasi

- Akses cairan
- Pengambilan darah

Langkah Singkat

1. Asepsis area
2. Pasang torniket
3. Tusuk vena
4. Fiksasi

Komplikasi

- Hematoma
- Infeksi

Bab 20.3 Pemasangan Kateter Urin**Indikasi**

- Retensi urin
- Monitoring urin output

Kontraindikasi Relatif

- Trauma uretra

Prinsip

- Teknik steril
- Jangan paksa

Bab 20.4 Nasogastric Tube (NGT)**Indikasi**

- Ileus (Kondisi gangguan pergerakan usus)
- Dekompresi lambung

Konfirmasi Posisi

- Aspirasi isi lambung

Bab 20.5 Basic Airway Management**Teknik Dasar**

- Head tilt–chin lift
- Jaw thrust
- OPA/NPA

Prinsip

- Oksigen dulu

Bab 20.6 Penjahitan Luka (Wound Suturing)

Penilaian Luka

- Bersih vs terkontaminasi

Langkah Umum

1. Anestesi lokal
2. Irigasi
3. Jahit

Bab 20.7 Injeksi & Obat Parenteral

Rute Umum

- IM (IntraMuscular)
- IV (IntraVena)
- SC (Subkutan)

Prinsip

- Dosis tepat
- Teknik benar

Bab 20.8 Roleplay Kasus Utama

Kasus: Pasien luka robek di IGD

Fokus Roleplay

- Persiapan alat
- Informed consent
- Teknik penjahitan

Bab 20.9 Kesalahan Umum Dokter Muda

Kesalahan	Risiko	Koreksi
Tidak steril	Infeksi	Asepsis
Paksa tindakan	Cedera	Stop & rujuk
Tidak jelaskan pasien	Konflik	Edukasi

Bab 20.10 Checklist Kompetensi Bab 20

Peserta kompeten bila mampu:

- Melakukan prosedur dasar

- Menjaga sterilitas
- Mengenali komplikasi
- Berkomunikasi baik

RINGKASAN

Bab ini menegaskan bahwa **keterampilan klinis adalah fondasi kepercayaan dan keselamatan pasien**. Teknik yang benar, aman, dan sadar batas kompetensi adalah kunci dokter yang profesional.